

[가상 회의 녹취록 원문] 을제병원 척추 다학제 컨퍼런스

회의 일시 : 2026년 6월 18일 07:30

장소 : 을제병원 본관 8층 MDT Conference Room

참석자

신경외과 교수 채송화
영상의학과 교수 윤세현
정형외과 교수 박도윤
심장외과 교수 김준완
신경외과 전공의(R3) 용석민
신경외과 전공의(R2) 허선빈
신경외과 치프 레지던트 안치홍

본 녹취록은 무료 버전 ChatGPT를 활용하여 초안을 작성한 **가상의 다학제 컨퍼런스 회의 녹취록**이며, 실제 의료기록이나 실제 환자 정보를 포함하고 있지 않습니다.

본 자료는 국내 대학병원의 다학제 컨퍼런스 진행 방식을 참고하여 LLM 회의록 요약 성능 비교를 위한 평가용 데이터로 작성되었으며, 특정 작품이나 실제 의료기관의 기록을 재현하거나 대체할 목적이 없습니다. 또한 상업적 이용을 목적으로 하지 않으며, 연구 및 성능 평가 목적으로만 활용되었습니다.

채송화

좋습니다. 시간 됐으니까 시작하겠습니다. 오늘 첫 번째 케이스는 외래에서 추적 중이던 흉추 척수병증 환자입니다. 영상 소견하고 임상 경과가 조금 일치하지 않는 부분이 있어서 다학제로 같이 논의하려고 올렸습니다. 석민 선생님, 환자 브리핑 부탁드립니다.

용석민

네, 교수님.
환자는 66세 남성으로 고혈압과 제2형 당뇨병으로 약물 치료 중이고, 3년 전 Coronary stent(관상동맥 스텐트) 시술 병력이 있습니다. 현재 Aspirin(아스피린)과 Clopidogrel(클로피도그렐)을 복용 중입니다.
주증상은 양측 하지 저림과 보행 장애입니다.
증상은 약 6개월 전부터 시작됐는데 최근 한 달 사이 악화 속도가 상당히 빨라졌습니다.
처음에는 계단 내려갈 때만 불편하다고 했는데 지금은 평지에서도 균형을 잘 못 잡고, 지팡이 없이 30미터 이상 걷기가 어렵습니다.
최근에는 단추를 잠그거나 젓가락질을 할 때도 손이 둔해졌다고 표현했습니다.
배뇨도 예전보다 시원하지 않다고 말씀하셨습니다.

채송화

상지 증상도 새로 생긴 거네요?

용석민

네. 아주 심한 정도는 아니지만 Fine motor control(미세운동 조절 능력)이 조금 떨어졌다고 표현했습니다.

허선빈

근력은 어느 정도였나요?

용석민

하지는 Medical Research Council(MRC, 근력평가척도) Grade 4 정도였습니다.
좌측이 우측보다 조금 더 약했고, 무릎 반사는 항진되어 있었고, Babinski sign(바빈스키 징후)은 양성이었습니다.

안치홍

감각 저하나요?

용석민

명확한 감각 레벨은 없었는데,
복부 아래쪽부터 둔한 느낌이 있다고 했습니다.

채송화

좋습니다. 영상 같이 보시죠.
윤교수님.

윤세현

네. 먼저 MRI(자기공명영상)부터 보겠습니다.
Sagittal T2(시상면 T2 강조) 영상입니다.
여기 보시면 T7-8 레벨에서 Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament(OPLL, 후종인대골화증)이 있습니다.
크기만 보면 아주 심한 OPLL은 아닙니다만
같은 레벨에 Hard disc(석회화된 추간판 탈출)도 일부 동반되어 있습니다.

박도윤

디스크 석회화는 꽤 오래된 것처럼 보이네요.

윤세현

네. 급성 병변이라기보다는 만성 변화에 가깝습니다.
그런데 문제는 이겁니다.
척수가 단순히 눌린 모습이 아닙니다.
여기 보시면 척수가 앞으로 길게 당겨진 것처럼 보입니다.
단순 Mechanical compression(기계적 압박)이라기보다는 Traction(견인)이 걸린 형태에 가깝습니다.

채송화

저도 그 부분이 계속 걸렸습니다.
처음 외래에서 볼 때도 압박 정도에 비해 척수가 너무 얇아 보였어요.

윤세현

맞습니다.
척수의 앞쪽 윤곽이 굉장히 날카롭게 변형되어 있습니다.
보통 OPLL에서는 이런 형태가 흔하지 않습니다.

허선빈

교수님. 이 정도 OPLL만으로도 Myelopathy(척수병증)는 충분히 설명되는 거 아닌가요?

윤세현

좋은 질문입니다. 설명은 일부 가능하지만
이 환자 영상은 압박보다 변형이 더 눈에 띕니다.
그게 조금 다릅니다.

채송화

그리고 임상 경과도 같이 봐야 합니다.
영상 하나만 보고 판단하면 안 됩니다.

용석민

교수님.
외래 기록 보니까 한 달 전에는 혼자 걸어 들어오셨는데 이번에는 보호자 부축을 받고 오셨습니다.
악화 속도가 생각보다 빨랐습니다.

채송화

그렇죠.
그게 가장 중요한 포인트입니다.
퇴행성 OPLL은 대부분 이렇게 한 달 사이에 급격하게 나빠지지는 않습니다.
물론 예외는 있지만 흔한 패턴은 아닙니다.

윤세현

그래서 저희가 생각한 감별진단은 세 가지입니다.
첫 번째는 Cord herniation(척수 탈출증).
두 번째는 Dorsal arachnoid web(배측 지주막 웹).
세 번째는 Arachnoid cyst(지주막 낭종)입니다.

박도윤

저는 Cyst 가능성은 조금 낮게 봅니다.
압박 양상이 낭종 같지는 않습니다.

윤세현

저도 동의합니다.
오히려 Web이나 Herniation이 더 의심됩니다.

안치홍

혹시 Scalpel sign(메스 징후)은 보이나요?

윤세현

그게 애매합니다.
전형적인 Scalpel sign이라면 고민이 덜했을 텐데,
이 환자는 아주 전형적이지 않습니다. 그래서 확신을 못 하고 있습니다.

채송화

정말 애매하네요.

윤세현

네. 이 환자는 영상만 보고 확진하기는 어려운 케이스입니다.

박도윤

그런데 임상은 영상보다 훨씬 심합니다.
저는 그 간극을 설명할 다른 병변이 있다고 생각합니다.

채송화

저도 비슷한 생각입니다.
영상만 보면 계획 수술로 생각할 수도 있는데,
실제 환자를 보면 그렇게 여유롭게 기다릴 상황은 아닙니다.

용석민

교수님.
혹시 추가 검사는 어떤 걸 먼저 고려하시는지요?

채송화

음... 조금 있다가 같이 논의해 봅시다.
우선 영상을 조금 더 보고.
윤교수님, 지금 상태에서 가장 필요한 검사가 뭡까요?

윤세현

저는 CT myelography(척수강 조영 CT)를 가장 먼저 고려하겠습니다.
MRI만으로는 척수 앞쪽 변형이 정확히 왜 생기는지 판단하기 어렵습니다.
조영제를 이용해서 Cerebrospinal Fluid(CSF, 뇌척수액) 흐름을 확인하면
Dorsal arachnoid web과 Arachnoid cyst를 어느 정도 구분할 수 있습니다.

허선빈

CSF flow가 막혀 있으면 Web 가능성이 더 높다는 말씀이신가요?

윤세현

네, 그렇습니다. 물론 100% 단언할 수는 없지만
CT myelography에서 흐름이 끊기는 위치와 모양을 보면 감별에 상당한 도움이 됩니다.

안치홍

Cord herniation도 확인 가능한가요?

윤세현

가능합니다.
특히 척수가 전방 경막 쪽으로 붙어 있는 모습이 보이면 의심할 수 있습니다.
다만 아주 초기 단계는 MRI와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.

채송화

결국 MRI 하나만으로는 부족하겠네요.

윤세현

맞습니다.
영상의 확산도는 아직 70~80% 정도라고 생각합니다.

박도윤

저는 조금 다른 의견입니다.
진단도 중요하지만 지금은 환자의 증상 진행 속도가 더 걱정됩니다.
지난 외래 기록을 보면 한 달 만에 보행 능력이 확연히 떨어졌습니다.
이 정도면 추가 검사 기다리다가 수술 시기를 놓칠 수도 있습니다.

채송화

저도 그 부분 때문에 회의를 요청했습니다.
영상은 애매한데 임상은 전혀 애매하지 않습니다.

용석민

교수님, 어제 병동에서 다시 진찰했는데 발목 클로누스도 관찰됐습니다.

채송화

몇 번 정도였습니까?

용석민

좌측은 5~6회 정도, 우측은 3회 정도였습니다.

채송화

그럼 지난주보다 조금 더 진행했네요.

허선빈

환자분도 "이번 주 들어 다리에 힘이 더 안 들어간다"고 계속 말씀하셨습니다.

채송화

그렇죠.
이런 경우에는 영상보다 환자를 믿어야 하는 경우가 있습니다.

박도윤

맞습니다.
영상은 어느 정도 주관적인 해석이 들어갈 수 있지만, 기능 저하는 거짓말을 하지 않습니다.

윤세현

다만 수술을 결정하기 전에 최소한의 영상 확인은 있어야 합니다.
혹시 실제 병변이 다른 위치라면 수술 계획 자체가 달라질 수 있습니다.

안치홍

교수님, 혹시 Dynamic MRI는 고려하지 않으시나요?

윤세현

좋은 의견입니다.
다만 흉추에서는 얻을 수 있는 정보가 제한적이고, 현재 환자 상태를 고려하면 검사 시간이 길어지는 것도 부담입니다.
저는 CT myelography가 더 실질적인 정보를 줄 것으로 생각합니다.

채송화

좋습니다.
그러면 영상 쪽은 CT myelography 우선으로 정리하고...
심장 상태도 같이 보겠습니다.
김교수님.

김준완

네.
차트는 미리 확인했습니다.
환자는 3년 전에 저희 병원에서 관상동맥 스텐트 시술을 받았고 이후 특별한 이슈는 없었습니다.
현재도 Aspirin과 Clopidogrel은 유지하고 있구요.

채송화

이 상태에서 수술하면 위험도가 어느 정도라고 보십니까?

김준완

두 가지 위험을 동시에 생각해야 합니다.
약을 계속 복용하면 Bleeding risk(출혈 위험)가 올라갑니다.
반대로 약을 갑자기 중단하면 Stent thrombosis(스텐트 혈전증) 위험이 증가합니다.

허선빈

그럼 어느 쪽이 더 위험한 건가요?

김준완

그 질문이 가장 어렵습니다.
환자마다 다른데...
스텐트 삽입 시기, 현재 심장 기능, 수술 종류를 모두 고려해야 합니다.

채송화

척추 수술은 출혈이 수술 결과에 직접 영향을 줄 수 있어서 고민이 더 큼니다.

김준완

그래서 저는 심장초음파와 Electrocardiography(ECG, 심전도)를 먼저 확인하고,
이후 항혈소판제 조정 계획을 세우겠습니다.

박도윤

수술을 며칠 미루는 건 가능하겠지만, 몇 주씩 기다리는 건 리스크 있습니다.

채송화

저도 같은 생각입니다.
지금은 진단을 완벽하게 만드는 것보다 신경학적 악화를 막는 것이 더 중요해 보입니다.
수술 후 예후도 그렇고.

윤세현

그렇다고 영상 확인 없이 들어가기에는 부담도 있지 않습니까..

용석민

교수님... 결국 검사와 수술 준비를 동시에 진행하는 방향으로 생각해야 할 것 같은데요.

채송화

네. 현재로서는 그 방향이 가장 현실적입니다.
다만 최종 결정 전에 마취과 의견도 반드시 들어야 합니다.

박도윤

동의합니다.
이 환자, 협진이 필수입니다.

채송화

좋습니다.
그러면 지금까지 나온 의견 정리하면서, 실제 수술 적응증과 우선순위 정리하고 마무리 합시다.
우선... 이 환자, 영상만 놓고 보면 원인을 특정하기 어려운 부분이 많았죠.
임상적으로는 더 이상 단순 경과 관찰을 할 단계는 아니었고요.

박도윤

네, 제가 특히 우려하는 게 악화 속도입니다.
퇴행성 척추질환은 대부분 수개월에서 수년에 걸쳐 진행되는 경우가 많은데, 이 환자는 한 달 사이에 보행 능력이 눈에 띄게 떨어졌습니다.
이 정도면 진행성 병변으로 판단하는 것이 맞겠습니다.

김준완

심장 쪽에서도 크게 반대할 이유는 없습니다.
다만 항혈소판제 관리 계획은 반드시 같이 세워야 합니다.
응급수술 수준은 아니지만, 그렇다고 일반적인 계획 수술처럼 일정을 미루는 것도 적절하지는 않아 보입니다.

윤세현

저도 같은 생각입니다.
영상의학과 입장에서는 CT myelography 결과가 있으면 훨씬 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.
하지만 결과를 기다리다가 환자의 신경학적 상태가 더 나빠지는 상황도 고려해야 합니다.

안치홍

교수님, 현재 감별진단의 우선순위는 어떻게 생각하십니까?

채송화

제 판단은 이렇습니다.
첫 번째는 Cord herniation.
두 번째는 Dorsal arachnoid web.
세 번째가 OPLL과 Hard disc에 의한 단순 압박입니다.
우선 Arachnoid cyst 가능성은 가장 낮게 보고 있습니다.

윤세현

사실 저도 거의 같은 의견입니다.
영상만 놓고 보면 Herniation과 Web 사이에서 고민되는 케이스입니다.

박도윤

저는 Herniation 쪽에 조금 더 무게를 두겠습니다.
척수 변형이 생각보다 심합니다.
OPLL, Hard disk 외적인 요인이 분명 있을거라 생각합니다.

허선빈

만약 실제 수술에서 Herniation이 아니라 Web으로 확인되면 수술 방법이 많이 달라지나요?

채송화

접근 방식이 일부 달라질 수 있습니다.

하지만 현재 가장 중요한 목표는 척수 압박을 해소하고 진행 중인 신경학적 악화를 막는 것입니다.

최종 병명이 수술 중 확인되는 경우도 적지 않으니까..

용석민

교수님, 환자와 보호자에게는 어느 정도까지 설명드리는 게 좋을까요?

채송화

진단이 하나로 확정되지 않았다는 점을 솔직하게 설명해야 합니다.

다만 지금 증상이 계속 진행하고 있고, 그 원인을 확인하면서 치료를 병행해야 한다는 점도 같이 말씀드려야 합니다.

괜히 확신하는 표현은 쓰지 마세요.

김준완

심장 쪽 설명도 같이 들어가야 합니다.

항혈소판제를 조절하는 과정에서 출혈 위험과 혈전 위험이 모두 존재한다는 점은 반드시 안내해야 합니다.

박도윤

보호자들이 "왜 진단이 확실하지 않은데 수술을 하느냐"고 질문할 가능성이 있습니다.

그 부분은 미리 충분히 설명하는 게 좋겠습니다.

채송화

맞습니다.

영상 검사와 임상 증상이 항상 완벽하게 일치하는 것은 아니라는 점도 설명해야 합니다.

이 환자는 임상 경과가 수술 결정을 더 강하게 뒷받침하고 있습니다.

윤세현

CT myelography는 오늘 오후 슬롯을 최대한 확보해 보겠습니다.

가능하면 결과도 오늘 안에 판독하겠습니다.

김준완

심장초음파와 ECG도 오늘 오전 중으로 진행하겠습니다.

필요하면 순환기내과에도 바로 협진을 의뢰하겠습니다.

안치홍

마취과 협진도 같이 넣겠습니다.

채송화

네.

마취과에는 출혈 위험과 신경학적 악화 가능성을 모두 전달해 주세요.

수술 일정이 빠르게 잡힐 가능성이 있다는 점도 같이 이야기하시고요.

용석민

환자는 입원 상태 유지하는 걸로 하면 될까요?

채송화

네.

현재 상태에서는 퇴원은 적절하지 않습니다.

운동 기능도 계속 나빠지고 있어서 낙상 위험도 있고요.

병동에서는 신경학적 진찰을 하루 두 번 정도 꼭 확인해 주세요.

허선빈

근력 변화나 감각 저하가 더 진행하면 바로 연락드리겠습니다.

채송화

좋습니다.

그리고 혹시라도 갑작스럽게 배뇨 장애가 심해지거나 하지 근력이 더 떨어지면 검사 결과를 기다리지 말고 바로 보고하세요.

그 경우에는 수술 시점을 더 앞당겨야 할 수도 있습니다.

김준완

오전에 검사하고 결과 나오면 아마 오후쯤 될 것 같은데 항혈소판제 조정 계획도 검토해서 공유드리겠습니다.

윤세현

영상 관련해서도 제가 직접 진행하고 판독결과 나오면 바로 연락드리겠습니다.

박도윤

현재까지 논의 내용을 보면 진료과 간 의견 차이는 크지 않은 것 같습니다.

검사는 최대한 신속하게 진행하되, 수술 준비도 동시에 시작하는 방향으로 이해하면 되겠습니까?

채송화

네, 그렇게 정리하면 되겠습니다.

검사 다 끝내고 결정하지 말고,

검사랑 수술 준비를 병행함으로써 환자의 신경학적 악화를 최소화합시다.

용석민 전공의

그럼 오늘 바로 보호자 면담도 진행하겠습니다.

채송화 교수

좋습니다.

보호자 면담 내용은 전자의무기록에 상세히 남겨 주세요.

특히 진단의 불확실성, 추가 검사 필요성, 수술 가능성, 심장 관련 위험도까지 모두 포함해서 기록해 주세요.

수술동의서도 곧 필요해질테니 준비하고.

안치홍

회의록은 제가 정리해서 각 진료과에 공유하겠습니다.

김준완

심장 쪽 결과도 확인되는 대로 이어서 공유하겠습니다.

윤세현

CT myelography 판독도 끝나는 대로 영상이랑 같이 첨부하겠습니다.

채송화 교수

좋습니다.

그럼 이 증례는 현재 진행성 흉추 척수병증(Progressive thoracic myelopathy)의 임상 경과를 보이며

원인 병변은 아직 완전히 확정되지 않았으나, 수술적 치료 가능성이 높은 상태로 정리하겠습니다.

각 진료과에서는 방금 논의한 일정대로 진행해 주시고, 결과들을 가지고 내일 오전 다시 짧게 논의하도록 하겠습니다.

수고 많으셨습니다.